

FENÓMENO DE RAYNAUD

Fernando Lozano, Boris A. Blanco Cáceres, Miriam Retuerto Guerrero

INTRODUCCIÓN

El fenómeno de Raynaud consiste en episodios paroxísticos reversibles de vasoconstricción periférica, típicamente en los dedos de manos y pies, en respuesta a determinados estímulos, ya sean físicos (exposición al frío), mecánicos (compresión, vibración), químicos (fármacos vasoconstrictores) o emocionales (estrés), aunque también pueden producirse espontáneamente.

La prevalencia de este fenómeno es de un 3-5% de la población general, con un predominio en el sexo femenino (7:1). La forma de presentación clásica consiste en cambios en la coloración de los dedos en tres fases secuenciales: palidez (fase de isquemia), cianosis (fase de hipoxia) y eritema (fase de reperfusión), aunque no siempre aparecen las tres fases (lo más frecuente es que sea bifásico). Los episodios se pueden acompañar de síntomas como sensación de frialdad, parestesias y dolor en la zona afecta, y su duración puede variar de minutos a horas.



El fenómeno de Raynaud puede ser:

- **Primario:** cuando aparece de forma aislada sin evidencia de ninguna enfermedad subyacente.
- **Secundario:** cuando se asocia a otra condición.

Las enfermedades subyacentes más frecuentes son las conectivopatías autoinmunes, principalmente la esclerosis sistémica (95%), aunque también se asocia a las miopatías inflamatorias, la enfermedad mixta del tejido conectivo o el lupus eritematoso sistémico entre otras. También puede asociarse a vasculitis, tromboangeítis obliterante o enfermedad de Buerger, aterosclerosis, tumores sólidos o hematológicos, trastornos neurológicos o endocrinos (hipotiroidismo).

DIAGNÓSTICO

Anamnesis

Debe recoger datos en relación con la forma de presentación y distribución del fenómeno de Raynaud, factores desencadenantes, edad de inicio del mismo y antecedentes familiares. El fenómeno de Raynaud primario suele debutar generalmente antes de los 30 años, tiende a tener un carácter simétrico, y los episodios suelen ser menos frecuentes, duraderos e intensos que en el caso del secundario, además de más frecuentemente asintomáticos (sin dolor asociado). Habitualmente existe asociación familiar (entre un 30-50% de los pacientes con fenómeno de Raynaud primario tienen un familiar de primer grado afecto). En el caso del secundario, la afectación del pulgar se produce con mayor frecuencia.

La anamnesis debe ir además dirigida a la búsqueda de signos y síntomas de enfermedad autoinmune: artralgias inflamatorias o artritis, rigidez matutina, mialgias, síntomas secos, fiebre, clínica constitucional, lesiones cutáneas, signos y síntomas de enfermedad cardíaca o respiratoria, dismotilidad esofágica, etc.

Además, es importante recoger un posible antecedente de consumo de fármacos o exposición a agentes tóxicos predisponentes (betabloqueantes, ergotamina, fármacos y drogas simpaticomiméticas, quimioterápicos como el cisplatino o la bleomicina, inhibidores de tirosina kinasas, etc.).

Examen físico

Debe dirigirse a la detección de datos de enfermedad autoinmune: edema de dedos o de manos, esclerodactilia, úlceras o cicatrices puntiformes en los dedos, telangiectasias, calcinosis, eritema periungueal, debilidad muscular, etc. Debe prestarse igualmente atención a la presencia de datos de enfermedad vascular: asimetría o ausencia de pulsos periféricos, asimetría en la medición de la tensión arterial en ambas extremidades, evidencia de lesiones tróficas con necrosis, úlceras y gangrena.

Pruebas complementarias

Aunque en general no disponible de forma urgente, el estudio básico del fenómeno de Raynaud ha de incluir una determinación de anticuerpos antinucleares (ANA) y una capilaroscopia, que siempre serán normales en el caso de un fenómeno de Raynaud primario pero pueden estar alterados en el secundario. Las alteraciones en la capilaroscopia (zonas de ausencias capilares, presencia de capilares dilatados, hemorragias) constituyen el mejor predictor de desarrollo de enfermedad subyacente.

Si se sospecha fenómeno de Raynaud secundario, se debe realizar un estudio analítico en función de los síntomas del paciente y de los hallazgos de la exploración:

- **Hemograma.**
- **Bioquímica** con glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, GOT, GPT, GGT, LDH, amilasa, proteínas totales, bilirrubina total y fraccionada, PCR y/o VSG, proteínas totales, electroforesis de proteínas séricas, niveles de complemento.
- **Coagulación básica**
- **Sistemático y sedimento de orina.**
- **Ecografía Doppler, angio-TC o angio-RMN:** Se puede solicitar en caso de sospecha de vasculopatía.

TRATAMIENTO

1. Medidas higienicodietéticas

Constituyen las primeras medidas que deben recomendarse siempre en el manejo del fenómeno de Raynaud. En muchos casos primarios, dichas medidas son suficientes para mantener un adecuado control sintomático y una buena calidad de vida, aunque los pacientes con fenómeno de Raynaud secundario suelen precisar medidas farmacológicas. Consisten en:

- Evitar la exposición al frío (no sólo de las zonas afectas, sino del cuerpo completo), así como los cambios bruscos de temperatura.
- Evitar la exposición ocupacional a factores físicos desencadenantes (traumatismos repetidos, vibración), además del estrés emocional.
- Evitar el hábito tabáquico, así como la exposición a fármacos vasoconstrictores (betabloqueantes, antimigrañosos, agentes simpaticomiméticos, etc).

2. Farmacológico

Bloqueantes de los canales de calcio dihidropiridínicos

Constituyen la primera línea de tratamiento médico. Disminuyen el número y la intensidad de los ataques. Los más utilizados son:

- **Nifedipino 10mg 1 cada 8h** dosis inicial.
- **Amlodipino 5mg 1 cada 24h** dosis inicial, pudiendo aumentarse la dosis progresivamente según la aparición de efectos adversos como mareo y cefalea, hasta 60 mg cada 8h el nifedipino y 10 mg cada 12h el amlodipino.

En caso de mala respuesta o tolerancia a los anteriores, otras alternativas son:

1. Antagonistas de los receptores de angiotensina II:

- **Losartán** a dosis de 25-100 mg/día o los

2. Antagonistas de receptores adrenérgicos alfa-1:

- **Prazosina** a dosis de 1-5 mg/día.

En caso de refractariedad a los fármacos anteriores, se pueden utilizar vasodilatadores más potentes:

Análogos intravenosos de la prostaciclina

Indicados en el fenómeno de Raynaud severo con lesiones isquémicas secundarias (siempre en el contexto de enfermedad autoinmune subyacente, como la esclerosis sistémica). Habitualmente se utilizan en ciclos cada 4-6 semanas. El más utilizado es el

- **iloprost** a dosis inicial de 0.5-2 ng/kg/min, que se va aumentando según tolerancia, durante al menos 6h al día, de 2 a 5 días consecutivos. Los efectos adversos más frecuentes son la aparición de cefalea, náuseas y vómitos.

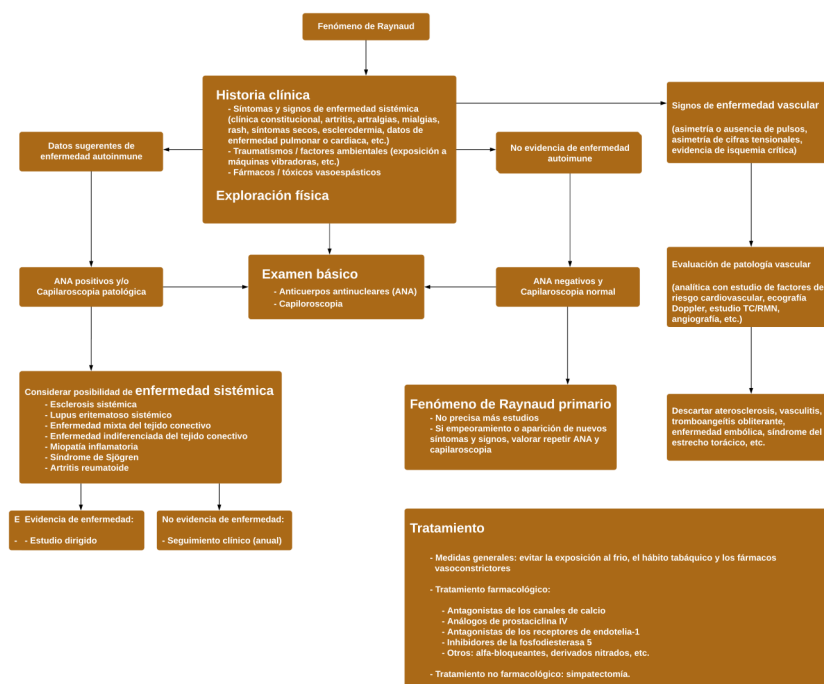
Inhibidores de la fosfodiesterasa 5 (PDE-5)

- **Sildenafil** dosis inicial de 20 mg/12h, hasta 40 mg/8h.
- **Tadalafilo** 20-40 mg/día.
- **Vardenafilo** 10 mg/12h.

Antagonistas de receptor de endotelina I

Indicados en la prevención secundaria de las úlceras isquémicas en pacientes con esclerosis sistémica. El más utilizado es.

- **Bosentán** dosis de 125 mg/12h.



BIBLIOGRAFÍA

- Linnemann B, Erbe M. Raynaud's phenomenon – assessment and differential diagnoses. *Vasa* 2015; 44: 166-177.
- Prete M, Fatone MC, Favoino E, Perosa F. Raynaud's phenomenon: from molecular pathogenesis to therapy. *Autoimmun Rev* 2014; 13: 655-667.
- Roustit M, Khouri C, Blaise S, Villier C, Carpentier P, Cracowski JL. Pharmacology of Raynaud's phenomenon. *Therapie* 2014; 69(2): 115-128.
- Kuryliszyn-Moskal A, Kita J, Hryniewicz A. Raynaud's phenomenon: new aspects of pathogenesis and the role of nailfold videocapillaroscopy. *Reumatologia* 2015; 53(2): 87-93.
- Wigley FM, Flavahan NA. Raynaud's phenomenon. *N Engl J Med* 2016; 375: 556-565.
- Maverakis E, Patel F, Kronenberg DG, Chung L, Fiorentino D, Allanore Y, et al. International consensus criteria for the diagnosis of Raynaud's phenomenon. *J Autoimmun* 2014; 0:60-65.